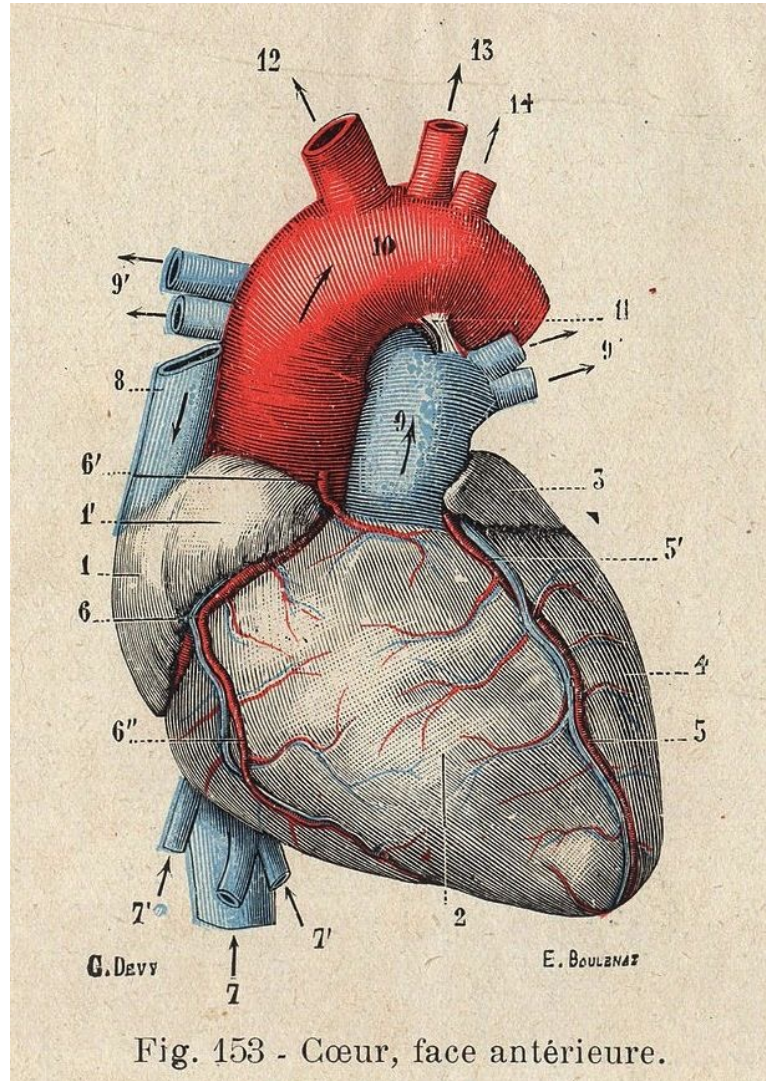


Cardiologie : Pathologies fréquentes



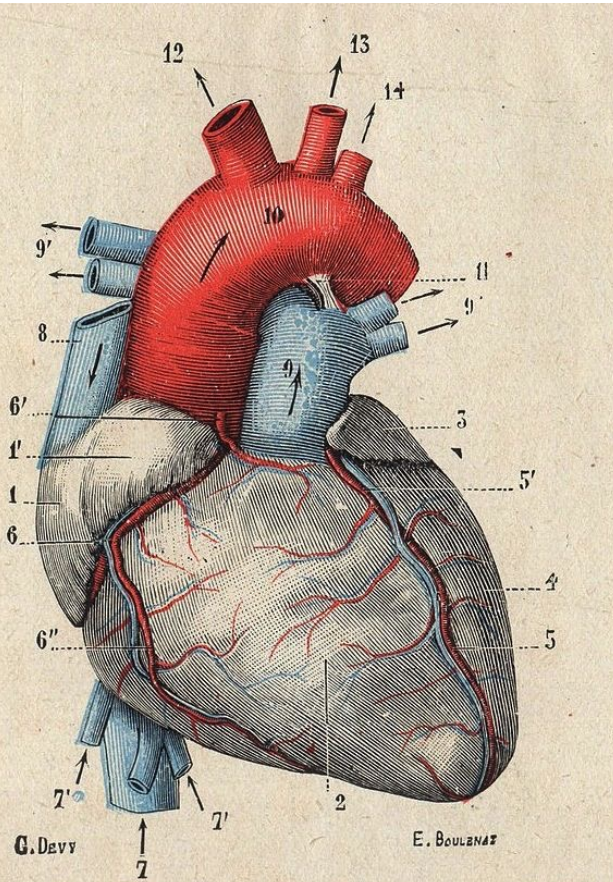
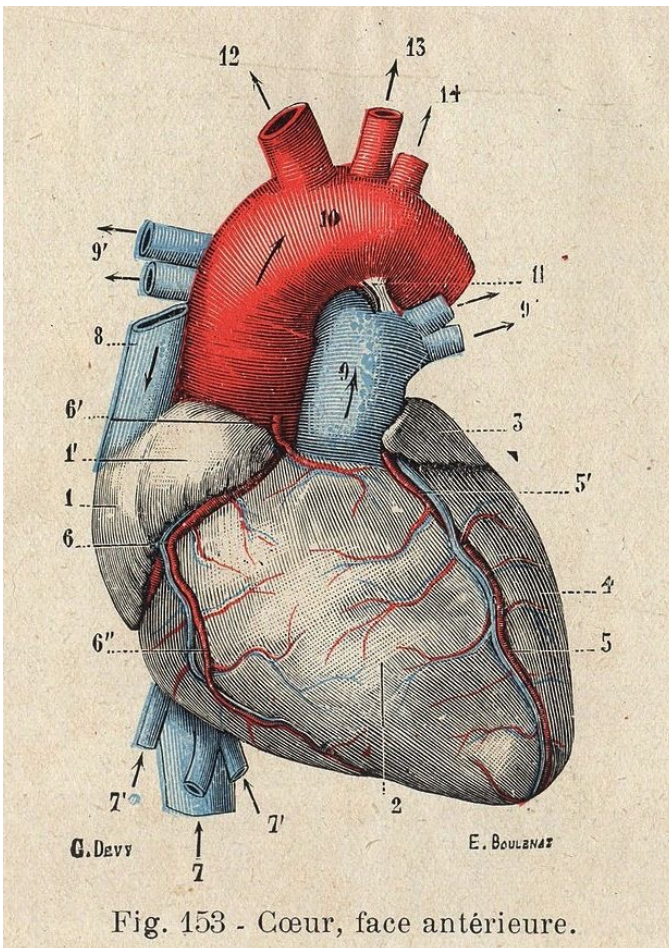


Fig. 153 - Cœur, face antérieure.

Angor et Infarctus du myocarde de type I :

- Définition :** Reflet de athérosclérose des artères coronaires, provoquant une diminution du flux sanguins et des symptômes associés à l'ischémie du muscle cardiaque. En fonction de la vitesse de développement de la sténose et de l'étendue du muscles touché, il existe trois présentation clinique :
 - L'angor stable** (50% des premières manifestations),
 - L'angor instable** (30% des premières manifestation) => '**angor instable sans augmentation des troponines**', '**NSTEMI**' et '**STEMI**'
 - La morte subite** (20% des premières manifestation).
- Cliniques:** **Douleurs rétro-sternale en étau, irradiant vers l'épaule G ou le cou.** Parfois, **épigastralgie** (femmes, ischémie inférieure). Aggravé par l'**effort** physique ou un **stress adrénergique** (froid, stress) et soulagé par le **repos** et les dérivés nitrés. Souvent accompagné de **nausée**, de **vertige** et de **dyspnée**. Les douleurs peuvent manquer chez les patients diabétiques (microangiopathie) ! Chercher les **FR CV typique** : LDL ↑, HDL ↓, tabac, surpoids, sédentarité, HTA, ANTCD familiaux < 55 ans (♂) ou 60 ans (♀), DM
- Diagnostic:**
 - ECG d'emblée si **angor instable** + dosage **TnT** et **CK-MB** puis selon résultats **coronarographie** et revascularisation
 - Si **angor stable typique**, consultation élektive et faire un ECG au **repos** puis à l'**effort** (stress physique ou pharmacologique). D'autres test sont également possible (PET et SPECT, CT, IRM, coronarographie).
- Traitement :**
 - Si **angor stable** => réduction des FR CV et traitement médicamenteux,
 - Si **angor instable**, d'emblée avant même le diagnostic :
 - O2 6 L/min** si Sa.O2 < 90%, **dérivé nitré** sublingual (**0.4 mg**) ou IV, **aspirine** (**500mg**) + **Clopidogrel** (**180mg**) po, + **héparine** 5'000 UI IV
 - Si STEMI, d'emblée **revascularisation**. Si NSTEMI, revascularisation en 24h à 72h discuter en fonction du taux TnT et de la clinique.



Endocardite infectieuse:

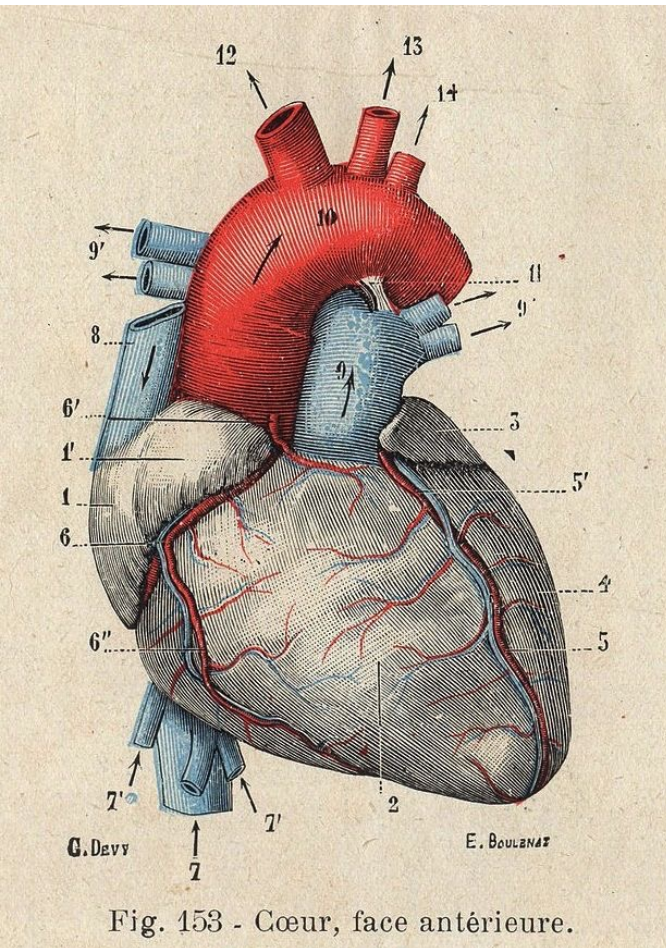
- **Cliniques:** Touche principalement le **cœur gauche** (valve mitrale ou aortique) chez des **individus prédisposés** (opération du cœur dans l'enfance ou valve prothétique) ayant été exposé à une **bactériémie transitoire** (par exemple : dentiste, infection...).
Exception : Cœur droite touché chez les '**intravascular drug user**'. Symptômes variées :
EF (>90% cas), **sudation**, diminution de l'état général, perte de poids, arthralgie
Souffle cardiaque nouveau, **insuffisance cardiaque** (OAP, œdème MI, turgescence veine jugulaire),
Symptômes cutanés : hémorragie en flammèche, nodule de Hosler (douloureux), lésion de Janeway (indolore)
Embole septique : AVC, insuffisance rénale, hémorragie rétinienne
Splénomégalie (cave: rupture splénique)
Deux types d'évolution : '**Endocardite aiguë**' (typiquement *S. aureus*) versus '**Endocardite lente**' (typiquement *S. viridans*)
- **Diagnostic:** Chercher des FR pour augmenter la suspicion, chercher à compléter les **critères de Duke**
US trans-thoracique (plus simple, moins sensible, VPP), **US trans-œsophage** (plus complexe, plus sensible, VPN).
Labo : **Hémoculture**, signe d'inflammation (leucocytose/CRP/VS), **signe d'insuffisance rénale**, Anémie (anemia of chronic disease)
- **Traitement** : Antibiothérapie prolongée (4-6 semaines voir plus), d'abord empiriquement puis centré sur le germe.
Si valve native : **Co-amoxicilline + Gentamycine** | Si valve prothétique : **Co-amoxicilline + Gentamycine + Rifampicine**
Éventuellement **opération** pour drainer abcès ou réparer une valve prothétique.
- **Notes** : Germe typique -> **Staphylocoques** (60%), **Streptocoque** (30%), **Entérocoque** (10%),
Rarement : '**HACEK**' (BGN fastidieux) ou *Bartonella sp*, *C. burnetii*, *Brucella sp*, *Legionella sp* et *Mycoplasma sp*

Endocardite Auto-immune:

- Rare, clinique similaire avec végétation sur une valve ou l'endocarde et une inflammation avec risque de thrombus.
- **Endocardite de Libman-Sacks** : dans le cadre d'un LES
- **Endocardite de Loeffler** : Endocardite avec hyper- éosinophilie, se retrouve dans différentes maladies dont l'asthme et les hyper- éosinophilie idiopathique.

Rhumatisme articulaire aiguë:

- **Cliniques:** Réaction auto-immune en réponse à une infection à *S. pyogenes*, avec réaction croisées des Ac contre les tissus
Apparition 1-3 semaines après l'infection des symptômes suivants : **pancardites** (endo-, myo- et péricardite)(≈100%)
Fièvre, **polyarthrite** (grosses articulation, ≈60%), **Atteintes cutanées** (érythème marginé rhumatismal ou érythème noueux, ≈30%)
éventuellement **chorée de Sydenham** (≈20%)
- **Diagnostic** : Présentation clinique et temporalité avec infection à streptocoque. **Critères de Jones**.
Présence d'anticorps caractéristique dans le sérum : anti-Streptolysine-A (**ASLO**) et anti-Desoxyribonucléase B
- **Traitement** :
Pénicilline V 10 jours pour éradiquer le *S. pyogenes* puis prévention des récives avec une dose 1x mois durant 5 ans,
Traitement de l'inflammation avec des **AINS** (aspirine) + **Cortisol**



Myocardite:

- **Cliniques:** **Dyspnée**, **douleurs thoracique 'angineuse'** (majoré à l'effort, soulagé au repos), **fatigue**, **palpitation** chez un jeune adulte. En général, apparition des symptômes concomitamment à une infection virale (angine, rhume, gastro-entérite...).
- **Notes:** La majorité du temps, causé par une réaction croisée entre la myocarde et des épitopes viraux (parvovirus B19, coxsackie, echovirus, EBV adenovirus). Parfois, cause **auto-immune** (arthrite rhumatoïde, vasculite, collagénose, sarcoïdose...) ou **post-radique**.
- **Diagnostic:** Principalement clinique et après exclusion d'une cause grave de douleurs thoracique (EP, infarctus). Auscultation en général sans particulier, parfois présence d'une **frottement péricardique** (en cas de péricardite associée) ou d'une **auscultation au galop** (en cas d'insuffisance cardiaque). Au laboratoire, signes d'inflammation (VS, CRP, Leucocytose) et signes de souffrances myocardique (élévation **TnT**, **CK/CK-MB**, éventuellement **NT-proBNP**). Un **ECG** est indispensable pour exclure un infarctus, mais des petites anomalies peuvent être visible (**sus-décalage concave et diffus de segment ST**, **négativisation de l'onde T**). Une imagerie peut-être effectuée mais n'est pas absolument nécessaire : **US**, **IRM** (permet de mettre en évidence un œdème diffus au niveau myocardique et d'exclure un infarctus) voir **coronarographie**. Dans des rares cas, une **biopsie** du myocarde.
- **Traitement :** **Repos stricte** durant les trois mois suivants (**pas de sport**), **AINS + Colchicine** (durant 3 mois) et RAD dans la majorité des cas (évolution spontanément favorable sous traitement). En cas d'atteinte fulminante, **hospitaliser** et éventuellement stimulateur cardiaque ou **ECMO** voir **transplantation**.
- **Complication :** En aigu, défaillance cardiaque. Après guérison, **cardiomyopathie dilatée** avec insuffisance cardiaque..

Péricardite et épanchement :

- **Cliniques:** **Dyspnée**, **douleurs thoracique respirationnel et ventilation-dépendante** (majoré à l'effort, à l'inspiration prolongé ou lors de toux, soulagé au repos et en **position assise/penchée en avant**). Les patients se tiennent dans une position antalgique typique. En général, apparition des symptômes concomitamment à une infection virale (angine, rhume, gastro-entérite...).
- **Notes:** Le plus souvent para-infectieux (**virale**) ou **idiopathique**. Parfois, la cause est **auto-immune** (sur RAA, vasculite...), post-infarctus (**syndrome de Dressler**), **oncologique** (épanchement péricardique malin) ou sur **syndrome urémique** (insuffisance rénale).
- **Diagnostic:** Principalement clinique et après exclusion d'une cause grave de douleurs thoracique (EP, infarctus). Palpation et auscultation d'un **pouls paradoxale** (cave danger si pouls paradoxal >10 mmHg), auscultation d'un **frottement péricardique**, parfois auscultation 'lointaine' (épanchement péricardique). Au laboratoire, on s'attend à des signes d'inflammation (VS, CRP, Leucocytose) et à des signes de souffrances myocardique (TnT, CK-MB, NT-proBNP). Un **ECG** est indispensable (typiquement une **sus-décalage concave et diffus de segment ST**). Une imagerie peut-être effectuée : **US** ou **IRM** (mise évidence épanchement), **Rx-thorax** (silhouette cardiaque '**en carafe**'). Si cas atypique, éventuellement drainage diagnostique du liquide ou Bx cardiaque, sérologie HIV, test Tb...
- **Traitement :** **Repos stricte** durant les trois mois suivants (**pas de sport**), **AINS + Colchicine** (durant 3 mois) et RAD dans la majorité des cas (évolution spontanément favorable sous traitement). En cas d'atteinte fulminante, **hospitaliser** et éventuellement stimulateur cardiaque ou **ECMO** voir **transplantation**.
- **Complication :** En aigu, évolution vers une **tamponnade cardiaque**. Après guérison, risque de **récidive** ou de **péricardite constrictive**.

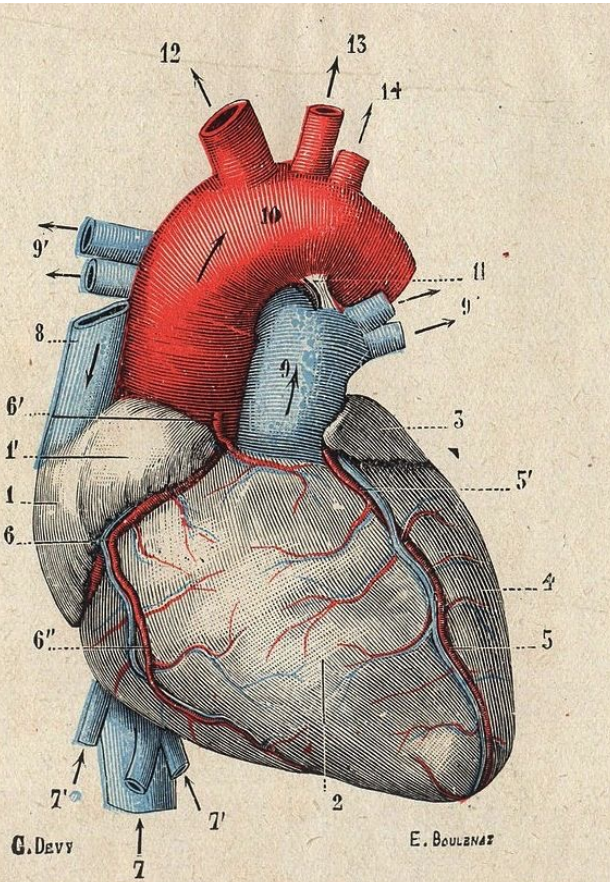


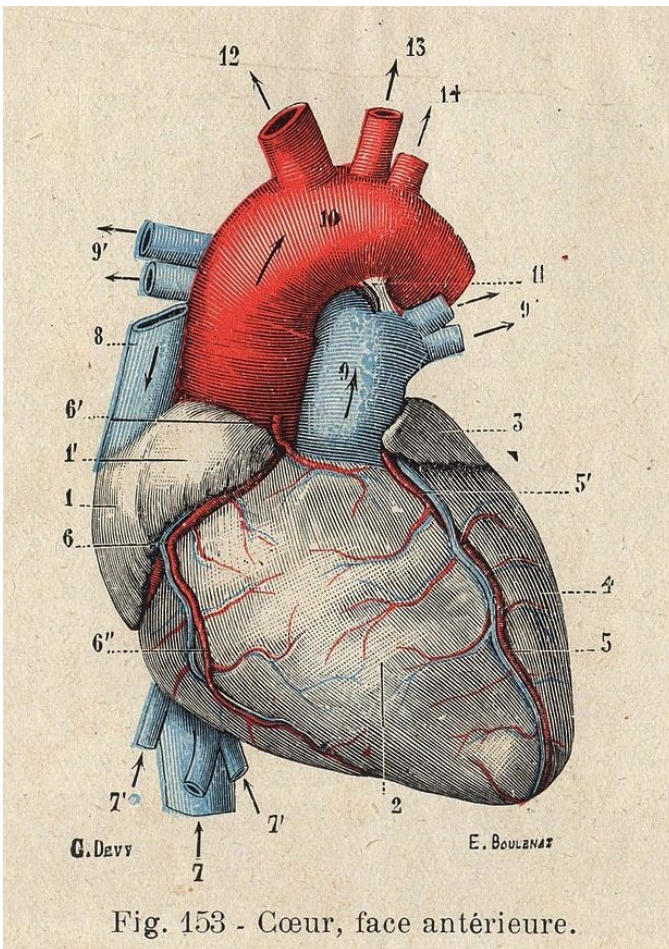
Fig. 153 - Cœur, face antérieure.

Tamponnade:

- Accumulation rapide de **300-400 mL** de transsudat/exsudat dans le péricarde avec diminution de la compliance cardiaque et **choc cardiogène**. Signes de **petits débits** (marbrures, extrémités froides), **d'insuffisance cardiaque** (OAP, œdème MI, turgescence jugulaire), signe **d'accumulation de liquide dans le péricarde** (auscultation lointaine, frottement péricardique, pouls paradoxale). **L'US** permet de confirmer le diagnostic et d'évaluer la fonction cardiaque.

Dissection aortique :

- **Cliniques:** **Douleurs transfixiante migrante**, d'abord thoracique, progressant en position interscapulaire puis lombaire.
- **Diagnostic:** Douleurs typiques, **T°A asymétrique** entre les deux bras, **Rx thorax caractéristique**. Chercher les FR typiques : **Âge**, **hypertension**, syndrome de **Marfan** ou **Ehlers-Danlos**, **vasculite** touchant les gros vaisseaux (syphilis, Takayasu), traumatisme avec **décélération brutale**. Confirmation du diagnostic et évaluation de la situation par **CT-injecté** (gold-standart), **TEE** ou **IRM**. ECG (possible infarctus surajouté en cas de dissection des artères coronaires). **Labo** : D-Dimère (élevée), TnT/CK-MB/NT-proBNP, Lactate (choc), Créatine (insuffisance rénale)
- **Traitement** : Contrôle de la **pression artérielle**,
Si dissection type A => **Chirurgie en urgence**
Si type B => **conservateur, endovasculaire**



Insuffisance cardiaque:

- Définition :** Incapacité du cœur à pomper suffisamment de sang à cause d'une anomalie structurelle ou fonctionnelle. Il s'agit d'un **syndrome clinique**, qui peut-être le reflet de différentes pathologies, mais pas d'un diagnostic **étiologique**. Distinction en trois groupes sur la base de la fraction d'éjection (EF) : Cette distinction guide les investigations et la thérapeutique.
 - HF-rEF :** Insuffisance cardiaque avec fraction éjection réduite (<40%) => **Chercher un problème systolique**
 - HF-pEF :** Insuffisance cardiaque avec fraction éjection conservée (<40%) => **Chercher un problème diastolique**
 - HF-mEF :** Insuffisance cardiaque avec fraction éjection intermédiaire (40-50%) => **Problème mixte ou compensé**
 On utilise également l'échelle de la NYHA pour grader les patients en fonction de leur dyspnée :
 - NYHA I / II / III / IV** => absence de symptôme / dyspnée après avoir monté 2 étages / après avoir monté 1 étage / à la moindre activité
- Cliniques:**
 - Insuffisance cardiaque droite : **Hépatomégalie** et **gastrite de stase**, **turgescence de la VJE**, **œdème** des MI
 - Insuffisance cardiaque gauche : **OAP** (dyspnée, orthopnée, toux nocturne, cyanose), **petit débits** (nycturie, fatigue, intolérance effort) Auscultation au galop (ventricules ne se vident pas complètement), épanchement pleural.
- Diagnostic:**
 - Labo : **NT-proBNP** (reste en fonction des DD), **ECG**
 - Rx-thorax** : **cardiomégalie** (silhouette cardiaque > 50% médiastin), **US** : insuffisance cardiaque et autres signes, **IRM**, **coronarographie**
- Traitement :**
 - Si possible : traitement causal ! Si besoin : **resynchronisation** (si arythmie), défibrillateur automatique implantable (**DAI**). Rarement, circulation extracorporelle (**ECMO**) ou **transplantation cardiaque**.
 - Un traitement médicamenteux efficace n'est possible que pour la HT-rEF : pril/sartan + BB + spironolactone + SGLT2i

IC systolique (HF-rEF)	Maladie coronaire, infarctus (60% de toutes les IC) HTA (stade tardif, dilaté) Pathologie valvulaire (sténose ou insuffisance) Cardiomyopathie dilaté Post-myocardite / auto-immune Toxique : OH, chimiothérapie Endocrine : hyper- et hypo-thyroïdie, Syndrome Conn, phéochromocytome, post-partum
---------------------------------------	--

IC diastolique (HF-pEF)	HTA, sténose valvulaire (stade initial, hypertrophie) Cardiomyopathie hypertrophique Pathologie infiltrative (Amyloïdose, Sarcoïdose, Hémochromatose) Sclérose systémique Maladie métabolique (DM, HT)
--	---